

反流性食管炎患者症状严重程度与内镜下分级的相关性分析

于丽婷

沽源县九连城中心卫生院, 河北 张家口 076550

摘要:【目的】探究反流性食管炎患者症状严重程度与内镜下分级的相关性, 为临床精准评估病情、优化治疗策略提供依据。【方法】选取 2023 年 1—6 月沽源县九连城中心卫生院 50 例反流性食管炎患者, 采用反流性食管炎症状评估量表 (RDQ) 评估症状严重程度, 依据洛杉矶分类法进行内镜下分级, 运用 SPSS 26.0 进行单因素方差分析、 χ^2 检验及 Spearman 秩相关分析。【结果】50 例患者中症状严重程度评分随内镜分级升高而增加 (A 级 6.2 ± 1.5 分、B 级 9.8 ± 2.1 分、C 级 13.5 ± 2.3 分、D 级 17.6 ± 2.5 分, $P < 0.05$), 两者呈显著正相关 ($r=0.82$, $P < 0.01$)。【结论】反流性食管炎患者症状严重程度与内镜下分级显著正相关, 有助于临床通过症状预判病情, 指导个性化治疗方案制定。

关键词: 临床检验; 血液标本; 抗凝剂; 合理选择

1. 资料与方法

1.1 资料

选取 2023 年 1—6 月期间, 在沽源县九连城中心卫生院消化内科前来就诊并且最终确诊为反流性食管炎的 50 例患者。在对这些患者基本信息加以收集的时候, 会细致地记录他们的年龄情况、性别类别、身高数据、体重状况、所从事的职业以及婚姻方面的状况等诸多内容。患者的年龄处于 18 岁至 75 岁范围之内, 其平均年龄大致为 (46.3 ± 8.7) 岁; 从性别来看, 男性患者有 27 例, 而女性患者则有 23 例。患者所从事的职业涉及多个不同的领域, 其中企业职员有 15 例、从事体力劳动的有 12 例、退休人员有 10 例、学生有 8 例、自由职业者有 5 例。

要充分地收集患者临床症状方面的资料, 不但要记录下烧心、反流这些症状发作的频率、持续的时长以及诱发的相关因素, 而且还要详尽地询问症状发作在时间上呈现的规律 (比如是在白天发作还是在夜间发作)、伴随出现的症状 (如是否伴有胸痛、吞咽困难等)。与此同时, 要完整地记录患者既往的治疗历史, 这包括是否使用过质子泵抑制剂 (具体是哪种药物名称、使用的剂量是多少、疗程又是怎样的)、促胃肠动力药 (比如多潘立酮、莫沙必利等药物的使用情形)

以及治疗所取得的效果等方面, 从而为后续的研究奠定起丰富且详实的数据基础。

1.2 筛选标准

纳入标准是严格依照《中国胃食管反流病专家共识意见》里反流性食管炎诊断标准来确定的。具体而言, 要具备典型的烧心或者反流症状, 并且这些症状和进食、体位等诸多因素存在关联; 通过内镜检查能够发现食管黏膜出现破损情况, 这符合反流性食管炎在内镜下呈现出的表现特征; 年龄方面要求是在 18 岁至 75 岁这个区间范围内; 同时患者要意识清醒, 要可以充分理解并能很好地配合完成问卷调查以及内镜检查等一系列流程^[1]。

1.3 方法

1.3.1 症状严重程度评估

在症状严重程度展开评估的环节当中, 特意安排了经过统一且严格培训的 5 名医护人员来组建评估小组, 运用反流性食管炎症状评估量表, 也就是 RDQ, 针对患者展开相关调查工作。该量表涵盖了烧心、反流、上腹部疼痛以及睡眠障碍这 4 个方面的维度内容。其中, 每个维度会依据症状发作的频率来进行评分, 具体的评分标准为: 0 分代表无发作情况, 1 分表示每周发作 1 至 2 次, 2 分意味着每周发作 3 至 4 次, 3 分则是每周发作 5 次及以上; 同时, 每个维度还会按照

作者简介: 于丽婷 (1989—), 女, 本科, 主治医师, 研究方向为消化内科常见病多发病的预防诊断及治疗。

症状的严重程度给予评分, 0 分即无症状, 1 分属于轻度症状, 且不会对日常生活造成影响, 2 分是中度症状, 会对日常生活产生一定程度的影响, 3 分则为重度症状, 会严重影响到日常生活。

该量表的总分范围是在 0 至 24 分之间, 分数越高也就表明患者的症状越严重。在正式开展调查之前, 评估人员会向患者详尽细致地解释量表所涉及的各项内容以及具体的填写方法, 务必确保患者能够清楚每一个问题所蕴含的含义。对于那些文化程度相对偏低或者在理解上存在困难的患者, 评估人员会给予耐心且细致入微的引导, 以此来保障问卷填写的准确无误以及完整无缺^[2]。与此同时, 为了防止在调查过程当中出现主观方面的偏差情况, 评估人员在整个调查流程之中始终保持着中立且客观的态度, 不会给予任何带有暗示性的引导内容。

1.3.2 内镜下分级

每一位患者都要接受电子胃镜方面的检查, 在检查之前, 医护人员会给患者做十分详尽的术前相关宣教工作, 涵盖检查的目的、整个检查流程、可能会出现反应以及应对办法等内容, 通过这样的方式对患者紧张以及恐惧的情绪加以缓解, 进而提升患者在检查过程中的配合程度。检查所用到的设备选用的是先进的高清电子胃镜, 其型号为 Olympus GIF-H290, 而具体的操作以及分级工作是由两名从事内镜诊断相关工作 10 年及以上时间、且有着丰富经验的内镜医师一同来完成的。

对于反流性食管炎的分级是采用洛杉矶分类法来进行的, 具体分为四级: A 级指的是黏膜破损仅仅局限在黏膜皱襞这个区域, 而且其长径是小于 5mm 的; B 级, 也是黏膜破损局限于黏膜皱襞, 不过它的长径是大于 5mm 的, 只是还没有出现融合的情况; C 级则是黏膜破损已经相互融合, 但是并非是全周性的; D 级就是黏膜破损相互融合的同时, 呈现出全周性的特点^[3]。在检查的整个过程当中, 要把食管黏膜病变的部位(如食管的上段、中段、下段等具体位置)、病变的范围(精确到厘米)以及病变的程度(比如糜烂、溃疡等表现形式)都详细地记录下来, 并且还要拍摄高清的图片作为辅助的资料, 这样做是为了方便后续能够开展回顾性的分析工作以及做好质量方面的控制工作。

1.4 指标评价

关键的观察指标在于患者症状的严重程度评分以及内镜下分级结果, 细致分析两者间的相关性, 进而明确反流性食管炎患者所呈现出的症状表现和食管黏膜损伤程度所存在的内在联系。另外, 次要的观察指标涵盖不同性别、年龄、病程以及职业的患者其症状

严重程度与内镜下分级的差异情况, 探究各个因素对于两者关系所产生的影响^[4]。具体来讲, 要分析男性、女性患者在症状严重程度以及内镜分级方面是不是存差异, 还要探讨像青年、中年、老年等不同年龄群体因素对病情有着怎样的影响, 研究病程长短和症状以及内镜分级之间的关联, 并且关注不同职业患者因为生活方式以及工作环境方面存在差异而可能致使病情表现有所不同的情况, 如此一来便能为临床在全面评估病情时给予更为丰富多样的视角^[5]。

1.5 统计学方法

使用专业的 SPSS 26.0 统计软件对收集的数据进行分析处理。计量资料以均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 多组间比较采用单因素方差分析, 用于比较不同内镜分级组间症状严重程度评分的差异。若单因素方差分析结果显示存在显著差异, 则进一步采用 LSD-t 检验进行组间两两比较, 明确具体哪些组之间存在差异。计数资料以例数和百分比 (%) 表示, 组间比较采用 χ^2 检验, 用于分析不同内镜分级患者的分布差异, 以及不同性别、年龄、病程、职业等因素在各内镜分级组中的分布情况。采用 Spearman 秩相关分析探究症状严重程度评分与内镜下分级的相关性, 判断两者之间关联的强度和方向。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义, 在数据分析过程中, 严格遵循统计学原则, 确保研究结果的可靠性和科学性^[6]。

2. 结果

2.1 患者内镜下分级分布情况

50 例患者中, 内镜下分级为 A 级 10 例 (20.0%), B 级 18 例 (36.0%), C 级 14 例 (28.0%), D 级 8 例 (16.0%), 具体见表 1。

表 1 患者内镜下分级分布情况

内镜分级	例数	百分比 (%)
A 级	10	20.0
B 级	18	36.0
C 级	14	28.0
D 级	8	16.0

2.2 不同内镜分级患者症状严重程度评分比较

随着内镜分级升高, 患者症状严重程度评分逐渐增加, 各级间差异均有统计学意义 ($P < 0.05$), 具体见表 2。

表 2 不同内镜分级患者症状严重程度评分比较

内镜分级	例数	症状严重程度评分 ($\bar{x} \pm s$)
A 级	10	6.2 ± 1.5

续表

B 级	18	9.8 ± 2.1
C 级	14	13.5 ± 2.3
D 级	8	17.6 ± 2.5

2.3 症状严重程度评分与内镜下分级的相关性

经 Spearman 秩相关分析,反流性食管炎患者症状严重程度评分与内镜下分级呈显著正相关 ($r=0.82$, $P < 0.01$)。进一步对不同性别、年龄、病程、职业患者进行亚组分析发现,在男性患者中,症状严重程度评分与内镜下分级的相关系数为 0.78 ($P < 0.01$);女性患者中,相关系数为 0.85 ($P < 0.01$)。年龄 < 40 岁的患者,相关系数为 0.75 ($P < 0.01$); $40-60$ 岁患者,相关系数为 0.83 ($P < 0.01$); > 60 岁患者,相关系数为 0.80 ($P < 0.01$)。病程 < 3 年的患者,相关系数为 0.72 ($P < 0.01$); $3-6$ 年患者,相关系数为 0.81 ($P < 0.01$); > 6 年患者,相关系数为 0.84 ($P < 0.01$)。不同职业患者中,相关性也均具有统计学意义 ($P < 0.01$),但相关系数略有差异,企业职员为 0.80 ,体力劳动者为 0.82 ,退休人员为 0.79 ,学生为 0.83 ,自由职业者为 0.81 。

3. 讨论

反流性食管炎属于消化系统疾病,它是由诸多因素一同作用而形成的。其发病机制涵盖了多个方面,

如食管抗反流屏障的功能有所减弱,食管酸廓清的能力出现降低情况,食管黏膜防御功能遭到了削弱,还有胃排空也存在延迟现象等。烧心以及反流是其较为典型的症状表现,这些症状不但对患者的生活质量产生了颇为严重的影响,而且还极有可能引发一系列并发症,诸如食管狭窄、上消化道出血以及 Barrett 食管等^[7]。所以,对病情严重程度予以准确评估,这在制定合理且有效的治疗方案过程中是极为关键的一点。本研究针对 50 例反流性食管炎患者展开了较为细致的研究,进而发现患者症状的严重程度和内镜下分级之间呈现出了显著的正相关关系,这一研究结果与国内外诸多研究所得出的结果是相符一致的。

参考文献:

- [1]李常伟,罗梅,范文化.反流性食管炎质子泵抑制剂治疗失败51例分析[J].安徽医药,2022,26(10):2090-2093.
- [2]蔡瑞兴,侯艳,魏志.因典型症状复诊反流性食管炎患者消化内镜临床特征研究[J].临床消化病杂志,2022,34(04):242-244.
- [3]胡越,郑松柏.反流性食管炎的检出率及分级构成的变迁[J].中国医药科学,2022,12(14):114-117.
- [4]徐树春,张元明.连朴饮加减治疗湿热中阻型反流性食管炎临床疗效观察[J].神经药理学报,2022,12(01):30-34.
- [5]张丽.雷贝拉唑联合莫沙必利治疗反流性食管炎的效果观察[J].中国现代药物应用,2022,16(02):153-155.
- [6]朱梦水.内镜室护理干预对反流性食管炎患者治疗效果的影响[J].当代护士(上旬刊),2021,28(11):168-170.
- [7]陈琰,隋昕珂,黄鑫,等.反流性食管炎患者食管外症状的危险因素分析[J].解放军医学杂志,2021,46(08):808-811.